ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

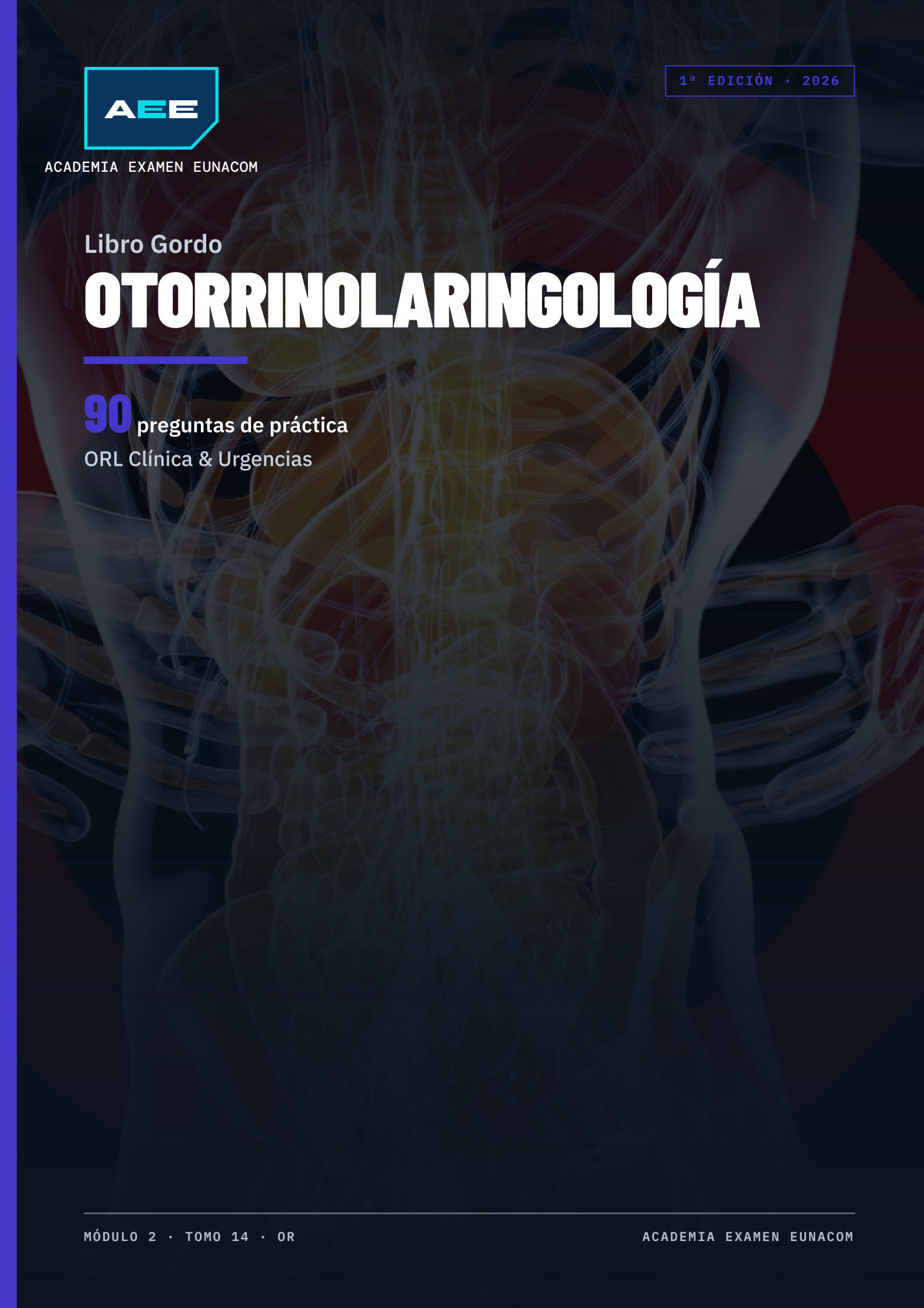
1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

OTORRINOLARINGOLOGÍA

90 preguntas de práctica

ORL Clínica & Urgencias



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Otorrinolaringología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO					
4.02.4.016	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 14 · 14.1 (Pág. 5)
4.02.4.017	Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q16, Q17	Tomo 14 · 14.3 (Pág. 11)
6.01.1.004	Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q13, Q14	Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9)
6.03.1.001	Alergia nasosinusal	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.007	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.008	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q9	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.018	Odinofagias crónicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.019	Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.020	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q10	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.021	Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q15	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.022	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.001	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q12	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.013	Hematoma nasoseptal	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
BLOQUE 2: AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO					
4.02.4.004	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q22, Q23, Q26, Q27, Q28, Q29	Tomo 14 · 14.5 (Pág. 20)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.03.1.009	Disfonías agudas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q19	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.014	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.026	Rinorreas agudas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q20	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.027	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q33	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.028	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.029	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.032	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.033	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.006	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.014	Otohematoma	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.017	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.018	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
BLOQUE 3: RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES					
4.02.4.012	Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q40, Q41, Q52, Q53	Tomo 14 · 14.9 (Pág. 35)
4.02.4.014	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q42, Q43, Q44, Q45	Tomo 14 · 14.11 (Pág. 39)
4.02.4.018	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q49	Tomo 14 · 14.12 (Pág. 43)
6.03.1.010	Disfonías crónicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.011	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.03.1.012	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q47	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.016	Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q54	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.024	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.030	Sinusopatías crónicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.011	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q48	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.012	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q51	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.015	Otorragia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
BLOQUE 4: FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR					
4.01.2.001	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q64, Q65, Q66, Q67	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.002	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q58, Q59, Q60, Q61	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.01.2.004	Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q71	Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56)
6.03.1.002	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q62	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.003	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.013	Estridor laríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.025	Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.031	Tinitus	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.002	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.003	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q69	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.004	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q70	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.016	Perforación timpánica traumática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q57	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Derivar			
BLOQUE 5: CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL					
4.02.5.001	Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q81, Q82	Tomo 14 · 14.19 (Pág. 69)
4.02.6.001	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q84, Q85	Tomo 14 · 14.20 (Pág. 71)
4.02.7.002	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76	Tomo 14 · 14.18 (Pág. 67)
6.03.1.004	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q86	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.005	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87, Q88	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.006	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q89	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.015	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.017	Odinofagias agudas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.023	Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.005	Atresia coanal congénita	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.007	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q77	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.008	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q78	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.009	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q79	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.010	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q80	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Otorrinolaringología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.001	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q64, Q65, Q66, Q67	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.002	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q58, Q59, Q60, Q61	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.01.2.004	Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q71	Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56)
4.02.4.004	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q22, Q23, Q26, Q27, Q28, Q29	Tomo 14 · 14.5 (Pág. 20)
4.02.4.012	Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q40, Q41, Q52, Q53	Tomo 14 · 14.9 (Pág. 35)
4.02.4.014	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q42, Q43, Q44, Q45	Tomo 14 · 14.11 (Pág. 39)
4.02.4.016	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q4, Q5, Q6, Q7	Tomo 14 · 14.1 (Pág. 5)
4.02.4.017	Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q16, Q17	Tomo 14 · 14.3 (Pág. 11)
4.02.4.018	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q49	Tomo 14 · 14.12 (Pág. 43)
4.02.5.001	Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q81, Q82	Tomo 14 · 14.19 (Pág. 69)
4.02.6.001	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q84, Q85	Tomo 14 · 14.20 (Pág. 71)
4.02.7.002	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76	Tomo 14 · 14.18 (Pág. 67)
6.01.1.004	Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista**	GES	Q13, Q14	Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9)
6.03.1.001	Alergia nasosinusal	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.002	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q62	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.003	Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q63	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.03.1.004	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q86	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.005	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87, Q88	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.006	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q89	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.007	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.008	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q9	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.009	Disfonías agudas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q19	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.010	Disfonías crónicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.011	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q46	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.012	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q47	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.013	Estridor laríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.014	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.015	Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q90	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.016	Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q54	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.017	Odinofagias agudas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.018	Odinofagias crónicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.019	Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.020	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q10	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.021	Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q15	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Colesteatomatosa	**Derivar**			
6.03.1.022	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.023	Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.024	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.025	Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.026	Rinorreas agudas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q20	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.027	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q33	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.028	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q34	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.029	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.030	Sinusopatías crónicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.031	Tinitus	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.032	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.033	Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.001	Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q12	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.002	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.003	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q69	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.004	Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q70	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.005	Atresia coanal congénita	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q74	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Derivar			
6.03.2.006	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.007	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q77	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.008	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q78	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.009	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q79	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.010	Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q80	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.011	Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q48	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.012	Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q51	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.013	Hematoma nasoseptal	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.014	Otohematoma	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.015	Otorragia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.016	Perforación timpánica traumática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.017	Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.018	Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

PREGUNTA 1 6.03.1.001

1. Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Antihistamínicos orales
B) Antibióticos orales
C) Corticoides tópicos
D) Derivar a cirugía de adenoides
E) Oximetazolina tópica

PREGUNTA 2 6.03.1.018

2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Odinofagias crónicas · 6.03.1.018] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Odinofagias crónicas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 6.03.2.013

3. Un paciente de 28 años presenta un pelotazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y luego sensación febril. Al examen físico se observa aumento de volumen bilateral, en relación al tabique nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Drenaje por punción con aguja fina
B) Drenaje quirúrgico con bisturí
C) Taponamiento anterior
D) Administrar analgésicos
E) Reducción en pabellón

PREGUNTA 4 4.02.4.016

4. Un lactante de 14 meses es diagnosticado de otitis media aguda derecha y se le prescribe amoxicilina en dosis de 85 mg/kg/día. A las 72 horas de tratamiento, la madre vuelve a consultar porque el niño persiste febril (38.8°C), muy irritable y con dolor en el oído. La otoscopía de control muestra persistencia del abombamiento y eritema timpánico. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada en este momento?

A) Aumentar la dosis de amoxicilina a 120 mg/kg/día y controlar en 48 horas.
B) Cambiar el tratamiento antimicrobiano a amoxicilina con ácido clavulánico oral.
C) Suspender la amoxicilina e iniciar gotas óticas de ciprofloxacino con hidrocortisona.
D) Derivar de urgencia para miringotomía y timpanocentesis inmediata.
E) Mantener la amoxicilina por 48 horas adicionales ya que el efecto bactericida puede tardar hasta 5 días.

PREGUNTA 5 4.02.4.016

5. Un niño de 4 años presenta cuadro de 2 días de rinorrea serosa y fiebre leve. Su madre nota que no responde adecuadamente cuando se le habla despacio. Al examen físico, el niño no tiene dolor ótico. La otoscopía revela tímpanos íntegros, de aspecto translúcido pero discretamente opacos y de color amarillento-ámbar, con presencia de nivel hidroaéreo y burbujas detrás de la membrana, sin eritema ni abombamiento. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta de elección?

A) Otitis media aguda; iniciar amoxicilina a 90 mg/kg/día por 10 días.
B) Otitis media con efusión; conducta expectante y control en 3 meses.
C) Otitis media crónica colesteatomatosa; solicitar TAC de peñasco urgente.
D) Otitis externa difusa; indicar gotas óticas de neomicina y polimixina B.
E) Disfunción tubárica aguda; iniciar corticoides orales y antihistamínicos por 14 días.

PREGUNTA 6 4.02.4.016

6. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el agente etiológico aislado con mayor frecuencia en la otitis media aguda bacteriana no complicada en Chile?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Streptococcus pneumoniae
C) Staphylococcus aureus
D) Klebsiella pneumoniae
E) Streptococcus pyogenes

PREGUNTA 7 4.02.4.016

7. Un lactante de 11 meses presenta su tercer episodio de otitis media aguda supurada en los últimos 4 meses, respondiendo satisfactoriamente a la amoxicilina en cada oportunidad. La madre pregunta cuál es la definición médica de su condición y el paso a seguir. ¿Cuál es la respuesta correcta?

A) Corresponde a una otitis media crónica supurada y debe iniciar profilaxis antibiótica diaria con cotrimoxazol.
B) Cumple criterios de otitis media recurrente y debe ser derivado al especialista otorrinolaringólogo para evaluación de tubos de ventilación.
C) No cumple criterios de recurrencia porque se requieren al menos 5 episodios en 6 meses.
D) Se trata de una falla inmunológica primaria y requiere inmunoglobulinas endovenosas mensuales.
E) Debe recibir amoxicilina en dosis profiláctica continua durante toda la temporada de invierno.

PREGUNTA 8 6.03.1.007

8. Una paciente de 48 años consulta por hipoacusia bilateral de 10 años de evolución, progresiva, que aumentó especialmente durante su último embarazo. Su otoscopía es normal y el examen neurológico no muestra alteraciones vestibulares ni cerebelosas. Se realiza test de diapasones, que muestra prueba de Rinne negativo bilateral y prueba de Weber que no lateraliza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipoacusia genética neurosensorial
B) Ototoxicidad
C) Otoesclerosis
D) Hipoacusia hormonal
E) Otitis media con efusión

PREGUNTA 9 6.03.1.008

9. [ATENCIÓN PRIMARIA: Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales · 6.03.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 10 6.03.1.020

10. Niño con antecedente de resfrío de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina/ Ac. clavulánico
C) Ciprofloxacino tópico
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

PREGUNTA 11 6.03.1.022

11. Un paciente de 47 años, con antecedente de perforación 8mpánica derecha de larga data, presenta otalgia y otorrea de dos días de evolución. Al examen Fsico, la otoscopía muestra la perforación 8mpánica conocida, con presencia de secreción amarillenta en relación al `mpano y al conducto audi8vo externo. ¿Qué an8bió8co es de elección para el tratamiento inicial de este paciente?

A) Neomicina tópica
B) Ciprofloxacino tópico
C) Amoxicilina oral
D) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
E) Cejriaxona endovenosa

PREGUNTA 12 6.03.2.001

12. [URGENCIA: Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica · 6.03.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 13 6.01.1.004

13. Un escolar de 6 años es evaluado en el policlínico por sospecha de déficit atencional, ya que en el colegio la profesora nota que no obedece las órdenes y pide con frecuencia que le repitan las frases. No ha tenido otalgia ni fiebre. A la otoscopía se aprecian membranas timpánicas íntegras, ligeramente retraídas, de color amarillento y con visualización de nivel hidroaéreo y burbujas bilaterales. La timpanometría arroja curvas tipo B bilaterales con hipoacusia de conducción de 25 dB. El cuadro se ha documentado por 4 meses consecutivos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Corticoides sistémicos orales en pulsos por 10 días.
B) Amoxicilina con ácido clavulánico por 21 días consecutivos.
C) Inserción bilateral de tubos de ventilación timpánica (colleras).
D) Realización inmediata de mastoidectomía bilateral abierta.
E) Tratamiento prolongado con antihistamínicos orales y descongestionantes nasales.

PREGUNTA 14 6.01.1.004

14. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen otoscópico orienta con mayor especificidad a una otitis media crónica colesteatomatosa por sobre una otitis media crónica simple?

A) Perforación central puntiforme en el cuadrante anteroinferior de la pars tensa.
B) Presencia de escamas blanquecinas nacaradas en una perforación marginal en la pars flácida.
C) Membrana timpánica abombada y eritematosa con pulsación visible.
D) Otorrea mucosa transparente no fétida a través de una perforación amplia que respeta el annulus.
E) Membrana timpánica íntegra con burbujas de aire retro timpánicas.

PREGUNTA 15 6.03.1.021

15. [ATENCIÓN PRIMARIA: Otitis media con efusión · 6.03.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Otitis media con efusión. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 4.02.4.017

16. Un joven de 22 años, aficionado al surf, consulta por dolor intenso en el oído derecho de 48 horas de evolución, acompañado de sensación de oído tapado y prurito. No ha tenido fiebre ni síntomas respiratorios. Al examen físico, la movilización del pabellón auricular y la palpación del trago provocan un dolor muy intenso. La otoscopía revela edema circunferencial eritematoso del conducto auditivo externo con detritos blanquecinos abundantes, sin permitir ver con claridad el tímpano. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días.
B) Aseo ótico y gotas óticas de ciprofloxacino con corticoide tópico por 7 a 10 días, asociado a analgesia oral.
C) Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas por 14 días y reposo laboral.
D) Lavado de oídos con abundante agua tibia a presión para despejar el conducto.
E) Hospitalización inmediata para administración de ceftriaxona endovenosa.

PREGUNTA 17 4.02.4.017

17. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente tanto de la otitis externa difusa aguda como de la otitis externa maligna necrotizante?

A) Staphylococcus epidermidis
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Moraxella catarrhalis

PREGUNTA 18 6.03.1.019

18. Un niño de 6 años presenta prurito en el oído derecho desde hace 3 días, al que ayer se agregó otalgia intensa. Al examen Fsico, presenta dolor intenso a la compresión del trago y, en la otoscopía, se observa edema del conducto audi8vo y presencia de secreción amarillenta. El `mpano se observa sin perforación, de aspecto grisáceo. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Forunculosis del conducto audi2vo externo
B) O22s externa
C) O22s media aguda
D) Colesteatoma
E) Candidiasis del oído

BLOQUE 2 AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

PREGUNTA 19 6.03.1.009

19. Una paciente de 27 años sufre atoro con un pedazo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persis8do con disfonía y carraspera. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar endoscopía diges2va alta
B) Solicitar radiogra:as de cuello
C) Solicitar TAC de cuello
D) Solicitar nasofibrolaringoscopía
E) Solicitar videodeglución

PREGUNTA 20 6.03.1.026

20. **Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:**

A) Amoxicilina oral
B) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
C) Corticoide tópico
D) Descongestionantes tópicos
E) Antihistamínicos orales

PREGUNTA 21 6.03.2.014

21. **[URGENCIA: Otohematoma · 6.03.2.014] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Otohematoma. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 22 4.02.4.004

22. **Un paciente consulta por hipoacusia en el oído izquierdo. Al examen con diapasón de 512 Hz, la prueba de Weber lateraliza hacia el oído derecho y la prueba de Rinne es positiva bilateralmente (VA > VO en ambos oídos). ¿A cuál de los siguientes diagnósticos orienta este patrón semiológico?**

A) Hipoacusia de conducción del oído izquierdo.
B) Hipoacusia sensorioneural del oído izquierdo.
C) Hipoacusia de conducción del oído derecho.
D) Audición perfectamente normal en ambos oídos.
E) Tapón de cerumen ocluyente en el conducto auditivo izquierdo.

PREGUNTA 23 4.02.4.004

23. **¿Cuál de las siguientes curvas de la clasificación de Jerger en la timpanometría se asocia de forma característica a la presencia de líquido seroso intratimpánico en la otitis media con efusión (OME)?**

A) Curva A (pico centrado a 0 daPa con amplitud normal).
B) Curva As (amplitud disminuida con presión normal).
C) Curva B (curva aplanada sin punto de máxima compliance).
D) Curva C (pico desplazado a presiones negativas menores a -100 daPa).
E) Curva Ad (amplitud muy aumentada por discontinuidad de cadena).

PREGUNTA 24 6.03.1.032

24. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno de deglución · 6.03.1.032] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno de deglución. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 6.03.1.033

25. **Un niño de 4 años presenta escaso vocabulario para su edad y confunde muchas palabras. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el estudio de este paciente?**

A) Evaluación fonoaudiológica
B) Potenciales evocados auditivos
C) Emisiones otoacústicas
D) Audiometría
E) Control en 6 meses

PREGUNTA 26 4.02.4.004

26. **Un hombre de 52 años consulta por pérdida súbita de la audición del oído derecho que notó al despertar hoy en la mañana, asociada a tinnitus agudo. No refiere dolor, fiebre ni secreción. A la otoscopía, ambos conductos auditivos externos están limpios y las membranas timpánicas son de aspecto normal. La prueba de Weber lateraliza al oído izquierdo y el Rinne es positivo en ambos oídos. ¿Cuál es la conducta inicial de elección que debe instaurarse de forma inmediata?**

A) Realizar lavado de oído bilateral con agua tibia para retirar eventual tapón de cera profundo.
B) Indicar descongestionantes orales y citar a control ambulatorio en 3 semanas.
C) Iniciar de inmediato prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día y solicitar audiometría urgente.
D) Prescribir gotas óticas de ciprofloxacino con hidrocortisona cada 8 horas por 7 días.
E) Tranquilizar al paciente indicando que se trata de un cuadro viral autolimitado que no requiere fármacos.

PREGUNTA 27 4.02.4.004

27. Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que 'oye pero no entiende'. No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?

A) Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES.
B) Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales.
C) Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida.
D) Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización.
E) Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1.

PREGUNTA 28 4.02.4.004

28. Un calderero industrial de 45 años, con 20 años de labor en maestranza sin uso constante de protectores auditivos, se realiza una audiometría ocupacional periódica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos audiométricos es característico y patognomónico del trauma acústico crónico por ruido laboral?

A) Pérdida auditiva de conducción con curva timpanométrica tipo B.
B) Caída del umbral auditivo neurosensorial en las frecuencias graves (250 a 500 Hz).
C) Muesca o escotoma neurosensorial bilateral selectivo en la frecuencia de 4000 Hz.
D) Brecha óseo-aérea de 30 dB en todas las frecuencias con vía ósea normal.
E) Caída plana sensorioneural de 90 dB en todas las frecuencias del oído derecho únicamente.

PREGUNTA 29 4.02.4.004

29. En un paciente con hipoacusia sensorioneural súbita idiopática de 48 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes estudios de neuroimagen es el de elección para descartar de forma definitiva una patología retrococlear como el neurinoma del acústico (schwannoma vestibular)?

A) Radiografía de cráneo en proyección transorbitaria.
B) Tomografía computarizada (TAC) de cerebro sin contraste.
C) Resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro y ángulo pontocerebeloso con gadolinio.
D) Angiografía cerebral por sustracción digital de arteria basilar.
E) Ecografía Doppler de arterias carótidas y vertebrales.

PREGUNTA 30 6.03.1.014

30. Lactante que llega sin test de audición a primer control:

A) Emisiones otoacústicas
B) Impedanciometría
C) Evaluación por fono
D) Audiometría
E) Reflejo cocleopalpebral

PREGUNTA 31 6.03.2.006

31. Una paciente de 33 años, consulta por otalgia y sensación de oído tapado, mayor a derecha. Refiere que el día anterior estuvo nadando, sumergiéndose a 1,5 metros de profundidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Otitis media aguda
B) Otitis media con efusión
C) Perforación timpánica
D) Otitis externa
E) Barotrauma

PREGUNTA 32 6.03.2.018

32. Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopía no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. ¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?

A) Impedanciometría
B) TAC de oído
C) TAC de cerebro
D) Prueba calórica
E) Audiometría

PREGUNTA 33 6.03.1.027

33. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome de apnea del sueño · 6.03.1.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome de apnea del sueño. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 34 6.03.1.028

34. Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuent

E) Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:
A) Rinofibroangioma bilateral
B) Rinitis alérgica
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Hipertrofia de adenoides

PREGUNTA 35 6.03.1.029

35. **Paciente de 50 años con episodios de vértigo rotatorio, tinnitus unilateral fluctuante e hipoacusia neurosensorial ipsilateral. Los síntomas duran horas. Audiometría disponible en una semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Ménière
B) Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)
C) Neuritis vestibular
D) ACV de fosa posterior
E) Schwannoma vestibular

PREGUNTA 36 6.03.2.017

36. **Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. El diagnóstico más probable es:**

A) Parálisis cocleovestibular
B) Vértigo postural
C) Hídrops endolinfático
D) Neuronitis vestibular
E) Neurinoma del acústico

BLOQUE 3 RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

PREGUNTA 37 6.03.1.010

37. **Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?**

A) TAC de cuello
B) TAC de tórax
C) Ecografía de cuello
D) Nasofibrolaringoscopía
E) Endoscopía digestiva alta

PREGUNTA 38 6.03.1.030

38. **Una paciente con un cuadro de 5 años de evolución de marcada obstrucción nasal y rinorrea acuosa. Se realiza una radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de los senos maxilares. Se solicita un TAC de cavidades paranasales que muestra engrosamiento de la mucosa de los senos etmoidales y maxilares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar fluticasona tópica
B) Realizar cirugía endoscópica nasal
C) Solicitar rinomanometría
D) Indicar tratamiento antibiótico
E) Iniciar antihistamínicos orales

PREGUNTA 39 6.03.2.015

39. **[URGENCIA: Otorragia · 6.03.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Otorragia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 40 4.02.4.012

40. **Un hombre de 32 años consulta por cuadro de congestión nasal, rinorrea amarillenta espesa y cefalea frontal opresiva de 12 días de evolución sin mejoría. Refiere haber utilizado paracetamol e inhalaciones de vapor sin experimentar alivio. No presenta fiebre actual ni alteraciones visuales. Al examen físico se aprecia descarga mucopurulenta en el meato medio a la rinoscopía anterior y sensibilidad a la palpación sobre ambos senos maxilares. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta de elección?**

A) Rinitis alérgica estacional; iniciar antihistamínicos orales y derivar a inmunoterapia.
B) Rinosinusitis viral no complicada; mantener analgesia sintomática exclusiva por 10 días más.
C) Rinosinusitis bacteriana aguda; iniciar tratamiento con amoxicilina oral por 7 a 10 días.
D) Sinusitis fúngica invasora; hospitalizar para debridamiento quirúrgico inmediato.
E) Poliposis nasal sobreinfectada; solicitar radiografía simple de cráneo en proyección de Waters.

PREGUNTA 41 4.02.4.012

41. **Un escolar de 8 años con rinosinusitis aguda presenta aumento de volumen y eritema palpebral izquierdo. Al examen físico se comprueba limitación en la aducción y abducción del ojo izquierdo, diplopía y proptosis del globo ocular. La agudeza visual se mantiene conservada. ¿A cuál de los siguientes estadios de la clasificación de Chandler corresponde este cuadro clínico?**

A) Estadio I: Celulitis preseptal o periorbitaria.
B) Estadio II: Celulitis orbitaria postseptal.
C) Estadio III: Absceso subperióstico.
D) Estadio IV: Absceso orbitario con pérdida visual.
E) Estadio V: Trombosis séptica del seno cavernoso.

PREGUNTA 42 4.02.4.014

42. Un niño de 9 años consulta en el servicio de urgencia por sangrado nasal derecho activo tras hurgarse la nariz. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente estable. Se realiza compresión bimanual de las alas nasales durante 15 minutos continuos con cabeza hacia adelante, pero al soltar persiste sangrado leve. Al colocar un algodón con vasoconstrictor y retirar bajo buena luz con espéculo nasal, se visualiza claramente un vaso sangrante superficial en la porción anteroinferior del tabique nasal derecho. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección a continuación?

A) Realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley de urgencia.
B) Cauterización química del vaso sangrante con bastón de nitrato de plata.
C) Indicar ácido tranexámico endovenoso y hospitalizar para observación.
D) Cauterización bilateral simultánea de ambas caras del tabique nasal.
E) Indicar al paciente mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante las próximas 4 horas.

PREGUNTA 43 4.02.4.014

43. Una paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial presenta epistaxis masiva que no ha cedido tras taponamiento anterior bilateral con Merocel, evidenciándose sangrado activo continuo y abundante por la faringe posterior. Se decide realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley. Respecto al manejo integral de esta paciente, ¿cuál de las siguientes medidas es una indicación OBLIGATORIA?

A) Alta inmediata a domicilio con indicación de retirar la sonda Foley a las 12 horas.
B) Hospitalización con monitorización de signos vitales e inicio de antibióticos profilácticos sistémicos.
C) Insuflar el balón de la sonda Foley con 25 mL de aire para asegurar hemostasia máxima.
D) Suspensión absoluta de toda hidratación parenteral y mantener presión arterial sistólica sobre 180 mmHg.
E) Realizar cauterización a ciegas con nitrato de plata de la pared posterior de la orofaringe.

PREGUNTA 44 4.02.4.014

44. ¿Cuál es la anastomosis arterial responsable de la gran mayoría de las epistaxis anteriores en niños y adultos jóvenes, localizada en la región anteroinferior del tabique nasal?

A) Plexo venoso pampiniforme.
B) Plexo de Kiesselbach (Área de Little).
C) Plexo venoso de Woodruff.
D) Arteria carótida interna terminal.
E) Arteria meníngea media.

PREGUNTA 45 4.02.4.014

45. ¿Por qué motivo está formalmente contraindicado realizar cauterización con nitrato de plata en ambas caras del tabique nasal de forma simultánea en una misma sesión?

A) Porque induce una crisis hipertensiva severa mediada por barorreceptores.
B) Por el riesgo de provocar isquemia, necrosis avascular y perforación septal permanente.
C) Porque aumenta el riesgo de desarrollar poliposis nasal alérgica difusa.
D) Porque desencadena parálisis del nervio olfatorio con anosmia irreversible.
E) Porque genera una sobreinfección inmediata por Pseudomonas aeruginosa.

PREGUNTA 46 6.03.1.011

46. [ATENCIÓN PRIMARIA: Epistaxis a repetición · 6.03.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Epistaxis a repetición. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 47 6.03.1.012

47. [ATENCIÓN PRIMARIA: Epistaxis leve · 6.03.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Epistaxis leve. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 48 6.03.2.011

48. [URGENCIA: Epistaxis masiva · 6.03.2.011] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Epistaxis masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 49 4.02.4.018

49. Un adolescente de 15 años sufre un pelotazo en la cara durante un partido de básquetbol, presentando deformidad nasal y epistaxis que cede espontáneamente. Al ser examinado en el policlínico de choque 6 horas más tarde, el médico realiza una rinoscopía anterior y constata un abombamiento violáceo, blando y bilateral en el tabique nasal que obstruye ambas fosas nasales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata que debe adoptarse?

A) Hipertrofia compensatoria de cornetes; indicar descongestionantes tópicos por 7 días.

B) Hematoma septal; realizar incisión, drenaje quirúrgico inmediato y taponamiento nasal bilateral compresivo.

C) Fractura nasal simple no desplazada; solicitar radiografía de huesos propios y citar a control en 10 días.

D) Poliposis nasal postraumática aguda; iniciar prednisona oral en dosis altas.

E) Desviación septal cartilaginosa fija; programar septoplastia electiva en 6 meses.

PREGUNTA 50 6.03.1.024

50. Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. Respira por la boca, por la obstrucción nasal. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante, que obstruyen completamente las fosas nasales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar fluticasona tópica c/12 horas

B) Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días

C) Solicitar TAC de cavidades paranasales

D) Realizar cirugía endoscópica nasal

E) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

PREGUNTA 51 6.03.2.012

51. [URGENCIA: Fractura nasal reciente · 6.03.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Fractura nasal reciente. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 52 4.02.4.012

52. Un estudiante de 24 años consulta por rinorrea acuosa profusa, prurito ocular y nasal intenso y salvas de estornudos que se presentan durante 5 a 6 días a la semana desde hace 2 meses coincidiendo con la primavera. Relata que se despierta en la noche con la nariz totalmente obstruida y que esto afecta su concentración para estudiar. A la rinoscopía anterior se aprecian cornetes inferiores hipertróficos y pálidos. De acuerdo con las guías clínicas internacionales (ARIA), ¿cuál es la clasificación de su enfermedad y el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Rinitis alérgica intermitente leve; clorfenamina oral 4 mg cada 8 horas.

B) Rinitis alérgica persistente moderada-severa; corticoide intranasal en spray diario (ej. fluticasona o mometasona).

C) Rinitis vasomotora pura; bromuro de ipratropio nasal según necesidad.

D) Rinosinusitis crónica poliposa; amoxicilina oral con ácido clavulánico por 21 días.

E) Rinitis alérgica persistente leve; oximetazolina nasal tópica cada 12 horas por 1 mes.

PREGUNTA 53 4.02.4.012

53. ¿Cuál es la causa subyacente y la conducta terapéutica correcta ante un paciente que presenta congestión nasal severa y empeoramiento clínico progresivo tras haber utilizado spray nasal de oximetazolina de venta libre de manera continua durante 4 semanas?

A) Sobreinfección bacteriana por Pseudomonas; indicar ciprofloxacino oral.

B) Rinitis medicamentosa por rebote vasomotor; suspender la oximetazolina e iniciar corticoides intranasales.

C) Poliposis nasal inducida por descongestionantes; derivar a cirugía endoscópica inmediata.

D) Desensibilización alérgica; aumentar la frecuencia de aplicación de oximetazolina a cada 4 horas.

E) Perforación del tabique nasal por toxicidad; realizar cauterización química urgente.

PREGUNTA 54 6.03.1.016

54. [ATENCIÓN PRIMARIA: Obstrucción nasal crónica · 6.03.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Obstrucción nasal crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

BLOQUE 4 FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

PREGUNTA 55 6.03.1.013

55. Lactante con estridor desde nacimiento causa a. Laringomalacia

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

PREGUNTA 56 6.03.1.031

56. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tinitus · 6.03.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tinitus. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 57 6.03.2.016

57. Una mujer de 32 años, consulta por dolor intenso en el oído izquierdo, que inició después de haberse limpiado con un cotonito (hisopo). No tiene síntomas vestibulares, aunque refiere hipoacusia moderada en dicho oído. Se realiza otoscopía, que muestra presencia de una perforación timpática triangular, con sangre en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado de oídos
B) Ciprofloxacino tópico
C) Derivar a timpanoplastía
D) Control en un mes
E) TAC de oídos

PREGUNTA 58 4.01.2.002

58. Un escolar de 7 años es traído a la consulta por fiebre de 38.6°C y odinofagia de 2 días de evolución. No tiene tos ni mucosidad nasal. Al examen físico destaca faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño con exudado pultáceo y adenopatías cervicales anteriores bilaterales muy sensibles a la palpación. Según los criterios de Centor modificados por McIsaac, ¿cuántos puntos tiene y cuál es la conducta de elección?

A) 2 puntos; manejo puramente sintomático con paracetamol oral.
B) 3 puntos; solicitar hemograma con frotis y radiografía de tórax.
C) 5 puntos; iniciar tratamiento antibiótico con penicilina benzatina IM o amoxicilina oral por 10 días.
D) 4 puntos; iniciar ciprofloxacino oral por 5 días para evitar nefropatía.
E) 1 punto; indicar gárgaras con sal y citar a control en 7 días si persiste con fiebre.

PREGUNTA 59 4.01.2.002

59. Respecto a las complicaciones de la faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) El tratamiento antibiótico precoz previene eficazmente la glomerulonefritis aguda postestreptocócica.
B) El tratamiento antibiótico con penicilina benzatina o amoxicilina por 10 días previene la fiebre reumática aguda.
C) La penicilina benzatina no tiene efecto en la prevención de abscesos periamigdalinos supurativos.
D) La glomerulonefritis solo se presenta tras infecciones estreptocócicas de la piel y nunca tras faringitis.
E) Se ha comprobado una tasa de resistencia a penicilina superior al 20% en cepas chilenas de Streptococcus pyogenes.

PREGUNTA 60 4.01.2.002

60. Un adolescente de 16 años consulta por odinofagia severa de 5 días de evolución, astenia marcada y fiebre. El médico sospecha amigdalitis bacteriana y le prescribe amoxicilina 875 mg cada 12 horas. Al tercer día de amoxicilina, el paciente acude a urgencias por la aparición de un exantema máculo-papular eritematoso difuso y pruriginoso en tronco y extremidades. Al examen actual presenta amígdalas hipertróficas con exudado blanco-grisáceo, adenopatías cervicales posteriores y epitrocleares palpables y esplenomegalia a 3 cm bajo el reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Alergia anafiláctica grave a la amoxicilina mediada por IgE.
B) Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr (EBV).
C) Escarlatina estreptocócica clásica con signo de Pastia.
D) Infección aguda por citomegalovirus refractaria a penicilina.
E) Shock tóxico estreptocócico fulminante.

PREGUNTA 61 4.01.2.002

61. En un paciente de 25 años con faringoamigdalitis estreptocócica confirmada por test rápido, con antecedente de reacción anafiláctica severa previa a la penicilina (edema de glotis y colapso circulatorio), ¿cuál de los siguientes antibióticos es la opción terapéutica de primera línea más adecuada?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral.
B) Cefadroxilo oral en dosis altas.
C) Azitromicina oral por 5 días.
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única.
E) Ampicilina oral por 10 días.

PREGUNTA 62 6.03.1.002

62. [ATENCIÓN PRIMARIA: Amigdalitis aguda · 6.03.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Amigdalitis aguda. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 63 6.03.1.003

63. [ATENCIÓN PRIMARIA: Amigdalitis crónica · 6.03.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Amigdalitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 64 4.01.2.001

64. **Un joven de 19 años con diagnóstico de amigdalitis aguda en tratamiento oral con amoxicilina desde hace 3 días consulta por agravamiento del cuadro. Presenta fiebre alta, odinofagia unilateral derecha intolerable, sialorrea profusa y marcada dificultad para abrir la boca. Al hablar se expresa con voz engorrosa apagada ('en papa caliente'). A la inspección orofaríngea se aprecia protrusión del pilar amigdalino anterior derecho con desplazamiento de la úvula hacia la izquierda. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección que debe realizarse de inmediato?**

A) Aumentar la dosis de amoxicilina oral al doble y asociar ketorolaco sublingual.

B) Punción con aguja o incisión y drenaje del espacio periamigdalino derecho e inicio de antibióticos endovenosos.

C) Solicitar tomografía computarizada de tórax ambulatoria para descartar masa tímica.

D) Intubación orotraqueal de urgencia y amigdalectomía bilateral en caliente inmediata.

E) Realizar laringoscopía indirecta con espejo para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales.

PREGUNTA 65 4.01.2.001

65. **Un lactante de 2 años presenta fiebre alta de 39.2°C, irritabilidad, rechazo alimentario, sialorrea y una postura fija del cuello en extensión con tortícolis dolorosa y estridor inspiratorio leve. En la radiografía lateral de cuello se evidencia un marcado ensanchamiento del espacio de partes blandas prevertebrales a nivel cervical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la complicación más temida de no mediar tratamiento urgente?**

A) Absceso retrofaríngeo; mediastinitis necrotizante descendente.

B) Croup viral laringotraqueal; estenosis subglótica adquirida.

C) Epiglotitis aguda; fístula traqueoesofágica espontánea.

D) Absceso periamigdalino bilateral; trombosis de arteria basilar.

E) Mononucleosis infecciosa severa; rotura esplénica retardada.

PREGUNTA 66 4.01.2.001

66. **¿Cuál es la causa del trismus (dificultad para la apertura bucal) característico que acompaña al absceso periamigdalino y al absceso parafaríngeo?**

A) Parálisis del nervio facial a nivel del canal estilomastoideo.

B) Compromiso inflamatorio y espasmo reflejo del músculo pterigoideo interno (medial).

C) Luxación traumática de la articulación temporomandibular.

D) Compresión directa del tronco del nervio trigémino en la fosa media.

E) Trombosis de la arteria carótida externa ipsilateral.

PREGUNTA 67 4.01.2.001

67. **Un paciente de 55 años con antecedentes de mala higiene dental consulta por aumento de volumen cervical anterior y submandibular bilateral de consistencia dura 'en madera', con dolor intenso. Al examen físico destaca fiebre, dificultad respiratoria, incapacidad para tragar la saliva y elevación forzada de la lengua que se encuentra empujada hacia el paladar y hacia atrás. ¿Cuál es la prioridad absoluta en el manejo médico inmediato de este paciente?**

A) Extracción inmediata en box de las piezas dentarias cariadas bajo anestesia local.

B) Asegurar y proteger la vía aérea de forma precoz (intubación guiada o traqueostomía).

C) Administración de corticoides orales en altas dosis y reposo en domicilio.

D) Solicitud de radiografía panorámica dental ambulatoria.

E) Punción evacuadora con trocar en el piso de la boca sin anestesia.

PREGUNTA 68 6.03.2.002

68. **Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abombamiento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:**

A) Absceso retrofaríngeo

B) Angina de Ludwig

C) Amigdalitis ulcero-necrótica

D) Absceso periamigdalino

E) Mononucleosis infecciosa

PREGUNTA 69 6.03.2.003

69. **[URGENCIA: Absceso profundo de cuello · 6.03.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Absceso profundo de cuello. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 70 6.03.2.004

70. **[URGENCIA: Absceso retrofaríngeo · 6.03.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Absceso retrofaríngeo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 71 4.01.2.004

71. **Un niño de 5 años presenta ronquidos nocturnos de 6 meses de evolución y pausas respiratorias nocturnas documentadas por sus padres de hasta 15 segundos con despertares sobresaltados y sudoración profusa. En el día respira con la boca abierta y presenta retraso pondoestatural. Al examen orofaríngeo se observan amígdalas palatinas grado 4 de Brodsky que contactan en la línea media. ¿Cuál es la conducta médica de elección más indicada?**

A) Tratamiento prolongado con antibióticos orales profilácticos por 6 meses.

B) Indicación quirúrgica de adenoamigdalectomía bilateral.

C) Uso exclusivo de descongestionantes nasales tópicos nocturnos.

D) Observación expectante hasta los 12 años esperando la involución fisiológica espontánea.

E) Tratamiento con estimulantes del sistema nervioso central para la hiperactividad.

PREGUNTA 72 6.03.1.025

72. **Un paciente de 80 años consulta por rinorrea bilateral, de tres meses de evolución, muy molesta, asociada a congestión nasal, que es más intensa en las mañanas y aumenta con los cambios de temperatura. El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer nasal

B) Pólipos nasales

C) Sinusitis bacteriana crónica

D) Rinitis vasomotora

E) Rinitis alérgica

BLOQUE 5 CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

PREGUNTA 73 6.03.1.017

73. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Odinofagias agudas · 6.03.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Odinofagias agudas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 6.03.2.005

74. **[URGENCIA: Atresia coanal congénita · 6.03.2.005] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Atresia coanal congénita. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 75 4.02.7.002

75. **Una madre acude al servicio de urgencia con su hijo de 3 años refiriendo que el niño se introdujo en la fosa nasal izquierda una pila de botón extraída de un juguete hace aproximadamente una hora. El niño presenta llanto y sangrado nasal escaso. Al examen se confirma la presencia de la batería en la fosa nasal. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada?**

A) Realizar lavado profuso de la fosa nasal con solución salina para neutralizar el pH y expulsar la pila.

B) Extracción inmediata del cuerpo extraño con gancho romo o derivación urgente a pabellón quirúrgico, sin realizar ninguna irrigación líquida.

C) Indicar descongestionantes orales y citar al policlínico de otorrinolaringología en 48 horas.

D) Instilar gotas de vaselina líquida para facilitar que la pila deslice hacia la nasofaringe.

E) Realizar compresión digital bimanual externa sobre el dorso nasal para aplastar la batería.

PREGUNTA 76 4.02.7.002

76. **Un niño de 4 años es traído a la consulta médica ambulatoria porque desde hace 3 semanas presenta mucosidad purulenta amarillenta que sale exclusivamente por la fosa nasal derecha, asociada a un olor fétido muy intenso. La madre refiere que ha sido tratado previamente con amoxicilina oral por sospecha de rinosinusitis sin ninguna mejoría. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable que debe descartarse en primer lugar?**

A) Rinitis alérgica estacional unilateral.

B) Cuerpo extraño nasal desapercibido en la fosa nasal derecha.

C) Atresia de coanas bilateral congénita tardía.

D) Fibrosis quística con sobreinfección por Pseudomonas.

E) Desviación septal cartilaginosa pura sin componente inflamatorio.

PREGUNTA 77 6.03.2.007

77. **[URGENCIA: Cuerpo extraño en el oído · 6.03.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cuerpo extraño en el oído. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 78 6.03.2.008

78. **[URGENCIA: Cuerpo extraño en el esófago · 6.03.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cuerpo extraño en el esófago. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 79 6.03.2.009

79. **Un paciente de 26 años, con antecedente de daño cerebral severo, desde hace 2 días presenta sialorrea, tos áfona, estridor inspiratorio y reticencia a alimentarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neumonía aspirativa

B) Epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo B

C) Crisis epiléptica focal

D) Cuerpo extraño laríngeo

E) Cuerpo extraño esofágico

PREGUNTA 80 6.03.2.010

80. **[URGENCIA: Cuerpo extraño nasal · 6.03.2.010] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cuerpo extraño nasal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 81 4.02.5.001

81. Un paciente de 50 años consulta por dolor y aumento de volumen agudo recurrente en la región submandibular derecha que aparece típicamente al comenzar a comer y cede gradualmente dos horas después. La palpación bimanual del piso de la boca revela una zona indurada milimétrica dolorosa a lo largo del trayecto del conducto salival. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el conducto excretor involucrado?

A) Parotiditis viral urliana; conducto de Stenon.
B) Sialolitiasis submandibular; conducto de Wharton.
C) Adenoma pleomorfo submandibular; conducto de Rivinus.
D) Ranula sublingual simple; conducto de Bartolino.
E) Angina de Ludwig inicial; conducto tireogloso persistente.

PREGUNTA 82 4.02.5.001

82. Una paciente de 42 años consulta por un nódulo indoloro en la región parotídea derecha que notó hace aproximadamente 1 año, de crecimiento muy lento. Al examen físico se palpa un nódulo de 2.5 cm en el polo inferior de la parótida derecha, de consistencia firme-elástica, superficie lisa, móvil, no adherido a planos profundos ni a la piel. La motilidad de la musculatura mímica facial es rigurosamente normal y simétrica en ambos lados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento quirúrgico de elección?

A) Carcinoma mucoepidermoide de alto grado; parotidectomía radical con sección del nervio facial y radioterapia.
B) Adenoma pleomorfo; parotidectomía superficial con disección y preservación del nervio facial.
C) Quiste branquial infectado; drenaje percutáneo ambulatorio e inicio de cloxacilina.
D) Sialometaplasia necrotizante; enucleación tumoral simple con bisturí frío en el box.
E) Parotiditis bacteriana crónica; tratamiento prolongado con amoxicilina-ácido clavulánico.

PREGUNTA 83 6.03.1.023

83. Un niño de 6 años es traído por su madre, dado que desde hace 2 horas comenzó con dolor y aumento de volumen en la zona paro`dea derecha. Al examen Fsico se palpa la glándula paró8da derecha aumentada de tamaño, dolorosa a la compresión. Al interrogatorio, la madre refiere que desde los 4 años ha presentado cuatro episodios similares, que han respondido al tratamiento con analgésicos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Sjögren
B) Paro2di2s viral recurrente
C) Li2asis del conducto de Stensen
D) Paro2di2s crónica
E) Tumor paroadeo

PREGUNTA 84 4.02.6.001

84. Un hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por una masa en la región lateral izquierda del cuello de 4 semanas de evolución, indolora y de consistencia pétrea de 3 cm de diámetro. Refiere además otalgia refleja izquierda ocasional con otoscopía rigurosamente normal. Respecto a la conducta diagnóstica inicial más apropiada, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el método de elección para la confirmación anatomopatológica y qué procedimiento está formalmente contraindicado?

A) Método de elección: Biopsia incisional abierta en pabellón bajo anestesia local. Procedimiento contraindicado: PAAF bajo ecografía.
B) Método de elección: Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía. Procedimiento contraindicado: Biopsia ganglionar abierta antes de descartar tumor primario en vía aérea superior.
C) Método de elección: Drenaje por aspiración con trócar grueso pensando en quiste sebáceo. Procedimiento contraindicado: Tomografía computarizada.
D) Método de elección: Exéresis completa de la glándula tiroides de urgencia. Procedimiento contraindicado: Nasofibroscopía flexible.
E) Método de elección: Ciclo empírico de cefadroxilo oral por 21 días. Procedimiento contraindicado: Evaluación por otorrinolaringólogo.

PREGUNTA 85 4.02.6.001

85. ¿Cuál de los siguientes síntomas constituye una bandera roja de sospecha oncológica que obliga a descartar prioritariamente un carcinoma escamoso de la base de la lengua, hipofaringe o laringe mediante nasofibroscopía?

A) Prurito ótico bilateral con descamación del conducto auditivo externo.
B) Otalgia persistente unilateral con examen otoscópico rigurosamente normal.
C) Hipoacusia de conducción que lateraliza al oído afectado en el test de Weber.
D) Estornudos en salva y rinorrea acuosa bilateral matinal.
E) Salida de secreción mucosa bilateral no fétida con tímpanos íntegros.

PREGUNTA 86 6.03.1.004

86. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de boca, labios y orofaringe · 6.03.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de boca, labios y orofaringe. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 87 6.03.1.005

87. Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y disfagia, a lo que se le ha agregado atoramiento con algunos alimentos y cambios en la resonancia de la voz. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer de esófago
B) Disfunción temporomandibular
C) Cáncer de hipofaringe
D) Faringitis crónica
E) Cáncer de laringe

PREGUNTA 88 6.03.1.005

88. Un paciente de 61 años, fumador, consulta por disfonía de 2 meses de evolución, asociada a aparición de una adenopatía cervical, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen inicial para el estudio de este paciente?

A) Radiografías de cuello
B) Endoscopía digestiva alta
C) Nasofibroscopía
D) Ecografía de cuello
E) TAC de cuello

PREGUNTA 89 6.03.1.006

89. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer nasosinusal · 6.03.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer nasosinusal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 90 6.03.1.015

90. Una paciente de 35 años, que cursa una infección respiratoria alta, presenta aparición de aumento de volumen cervical progresivo, de localización suprahioidea. A la palpación, se constata consistencia gomosa y se observa que asciende al solicitarle a la paciente que protruya la lengua. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Nódulo 2roideo
B) Quiste dermoide
C) Adenopaaa cervical
D) Quiste del conducto 2rogloso
E) Linfoma

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 — Respuesta: A — Alergia nasosinusal

6.03.1.001 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una rinitis alérgica, sin obstrucción (los corticoides tópicos serían si hubiese obstrucción)

PREGUNTA 2 — Respuesta: A — Odinofagias crónicas

6.03.1.018 · Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Odinofagias crónicas" (6.03.1.018), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 3 — Respuesta: B — Hematoma nasoseptal

6.03.2.013 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

El hematoma del tabique nasal se debe drenar de inmediato, mediante incisión amplia con bisturí (también el hematoma del pabellón auricular). De lo contrario evoluciona con necrosis avascular del cartílago.

PREGUNTA 4 — Respuesta: B

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

4.02.4.016 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo · GES

La opción correcta es la B. La persistencia de fiebre y otalgia con persistencia de signos otoscópicos a las 48-72 horas de tratamiento con amoxicilina a dosis altas constituye una falla terapéutica de primera línea. El mecanismo fisiopatológico principal es la infección por cepas de Haemophilus influenzae no tipificable o Moraxella catarrhalis productoras de betalactamasas. La conducta estandarizada por MINSAL y guías internacionales es el cambio inmediato a amoxicilina-ácido clavulánico (80-90 mg/kg/día de componente amoxicilina en relación 14:1). Opción A: Incorrecta, dosis superiores de amoxicilina sola no superan la resistencia por betalactamasas. Opción C: Incorrecta, las gotas óticas no penetran a través de una membrana timpánica íntegra. Opción D: Incorrecta, la timpanocentesis se reserva para mastoiditis, sepsis o recién nacidos. Opción E: Incorrecta, la falta de respuesta a las 72h exige cambio de antibiótico.

PREGUNTA 5 — Respuesta: B

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

4.02.4.016 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo · GES

La opción correcta es la B. La presencia de líquido o burbujas en el oído medio con membrana timpánica retraída o en posición neutra, sin signos inflamatorios agudos (sin eritema ni abombamiento) y sin sintomatología aguda (sin otalgia ni fiebre alta), define a la Otitis Media con Efusión (OME u otitis serosa). La inmensa mayoría de los casos resuelve espontáneamente en un período de 8 a 12 semanas. La conducta recomendada por guías clínicas es la observación expectante durante 3 meses. Ni los antibióticos, ni los corticoides, ni los antihistamínicos han demostrado beneficio y están desaconsejados. Si la efusión persiste pasados los 3 meses y se acompaña de hipoacusia bilateral significativa (> 20-30 dB), se indica la colocación de tubos de ventilación timpánica.

PREGUNTA 6 — Respuesta: B

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

4.02.4.016 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo · GES

La opción correcta es la B. Streptococcus pneumoniae (neumococo) continúa siendo el patógeno bacteriano más frecuente y clínicamente agresivo en OMA, responsable del 35-40% de los casos confirmados por timpanocentesis, seguido de Haemophilus influenzae no tipificable (30-35%) y Moraxella catarrhalis (10-15%). Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son agentes de otitis externa o de otitis media crónica supurada, no de OMA no complicada.

PREGUNTA 7 **Respuesta: B**

4.02.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

La opción correcta es la B. La OMA recurrente se define como la presencia de ≥ 3 episodios bien documentados de OMA en 6 meses, o ≥ 4 episodios en 12 meses (con al menos 1 en los últimos 6 meses). Este paciente (3 episodios en 4 meses) cumple cabalmente la definición y debe ser derivado a ORL para evaluar inserción de tubos de ventilación timpánica (colleras), lo cual previene nuevos episodios y protege la función auditiva. La quimioprofilaxis antibiótica prolongada está contraindicada por generar resistencia bacteriana.

PREGUNTA 8 **Respuesta: C**

6.03.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

Otoesclerosis: La prueba de Rinne es positiva en hipoacusias sensorioneurales y negativa en hipoacusias de conducción, como en este caso. La prueba de Weber lateraliza al lado afectado en la hipoacusia de conducción y al lado sano en la sensorioneural; pero si la hipoacusia es bilateral y simétrica, no lateraliza. La otoesclerosis y la otitis media con efusión son hipoacusias de conducción, pero el curso crónico por 10 años y el empeoramiento durante el embarazo son característicos de la otoesclerosis. Esta última es la causa más común de hipoacusia de conducción con tímpano normal, a diferencia de la otitis media crónica que presenta alteraciones timpánicas. Las hipoacusias sensorioneurales, en cambio, tienen tímpano sano en la otoscopía.

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

6.03.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales" (6.03.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 10 **Respuesta: A**

6.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 128). Evalúa el manejo clínico de Otitis media aguda según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

6.03.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

Tiene una oGGs media crónica simple, cuyo tratamiento de primera línea es tópico, con ciprofloxacino. La neomicina tópica Gene riesgo de ototoxicidad directa, por ser un aminoglicósido. Los antibióticos sistémicos se usan en los casos complicados (ej. mastoidiGs, laberintiGs). La cirugía está indicada en los casos refractarios y en caso de que haya un colesteatoma asociado.

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

6.03.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica" como urgencia clínica (6.03.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 13 **Respuesta: C**

Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Otitis Media con Efusión (OME) crónica persistente por más de 3 meses, acompañada de hipoacusia conductiva bilateral documentada que está interfiriendo en su rendimiento escolar y comunicación. Cuando la OME persiste más allá del período de observación de 3 meses con impacto auditivo (> 20-25 dB), la indicación formal y de elección es la miringotomía con colocación de tubos de ventilación timpánica (colleras), la cual restablece la ventilación de la caja timpánica y normaliza los umbrales auditivos de inmediato. Las opciones A, B y E carecen de efectividad demostrada en guías clínicas y exponen a efectos adversos innecesarios. La opción D es un procedimiento quirúrgico mayor para colesteatoma o mastoiditis, no para OME.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. Las características patognomónicas del colesteatoma en la otoscopía son la perforación marginal (que compromete el reborde óseo o annulus), habitualmente localizada en la pars flácida (ático) o cuadrante posterosuperior, a través de la cual protruyen detritos blanquecinos de queratina (escamas nacaradas) y pólipos inflamatorios con secreción purulenta de olor fétido. En contraste, la OMC simple presenta perforación central en la pars tensa respetando el annulus con otorrea mucosa no fétida (opciones A y D). La opción C describe una OMA supurada hiperaguda y la opción E describe una OME serosa.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

6.03.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Otitis media con efusión" (6.03.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: B**

Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

4.02.4.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. El caso corresponde a una clásica Otitis Externa Difusa Aguda (oído de nadador), producida habitualmente por Pseudomonas aeruginosa y favorecida por la exposición al agua. El signo del trago intensamente positivo es el sello clínico. En ausencia de signos de diseminación periauricular o inmunosupresión, el tratamiento de elección es estrictamente local: aspiración o aseo suave de los detritos del CAE y aplicación de gotas óticas que contengan fluoroquinolonas (Ciprofloxacino) asociadas o no a corticoides (Dexametasona) para reducir el edema, junto a analgesia oral con AINEs y protección estricta del agua. Los antibióticos orales (opciones A y C) no son necesarios y tienen menor eficacia local. El lavado con agua a presión (opción D) está contraindicado ya que agrava la inflamación y puede lesionar el conducto o el tímpano.

PREGUNTA 17 **Respuesta: B**

Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

4.02.4.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gramnegativa que causa más del 70-80% de las otitis externas difusas y más del 95% de las otitis externas malignas necrotizantes en pacientes diabéticos. Su afinidad por medios húmedos y su producción de exotoxinas y proteasas facilitan la invasión dermoepidérmica y la osteólisis del hueso temporal.

PREGUNTA 18 **Respuesta: B**

Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

6.03.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Es una oGGs externa clásica, de Gpo difuso, probablemente por Psdeudomonas aureginosa. Se trata con ciprofloxacino tópico. La otomicosis por cándida, Gene prurito generalmente con poco dolor y la secreción suele ser grumosa y blanquecina.

PREGUNTA 19 **Respuesta: D** **Disfonías agudas** 6.03.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Todas disfonía persistente se evalúa con nasofibrolaringoscopía (NFL). Además, el antecedente de cuerpo extraño y maniobra de Heimlich hacen sospechar una lesión laríngea o de las cuerdas vocales, parálisis cordal o cuerpo extraño residual, que se objetivarían con la NFL.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A** **Rinorreas agudas** 6.03.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los demás síntomas.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A** **Otohematoma** 6.03.2.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Otohematoma" como urgencia clínica (6.03.2.014), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. En el Test de Weber, el sonido lateraliza hacia el oído contralateral (sano) en las hipoacusias sensorioneurales; al lateralizar al oído derecho, indica que el oído izquierdo es el hipoacúsico sensorioneural. Además, el Test de Rinne positivo bilateral (VA > VO) confirma que no hay alteración de la conducción en el oído izquierdo, ya que las hipoacusias sensorioneurales conservan un Rinne positivo (la vía aérea sigue siendo más eficiente que la vía ósea, aunque ambas estén proporcionalmente descendidas). Una hipoacusia de conducción izquierda (opciones A y E) mostraría Weber al oído izquierdo y Rinne negativo izquierdo.

PREGUNTA 23 **Respuesta: C**

Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. La curva tipo B de Jerger es una curva plana, caracterizada por la ausencia de un pico móvil de compliance timpánica debido a la presencia de líquido no compresible (exudado o transudado seroso) en la cavidad del oído medio que impide la movilidad del tímpano ante los cambios de presión. Es el hallazgo timpanométrico clásico de la Otitis Media con Efusión (OME). La curva A es normal, la curva As indica rigidez (otoesclerosis), la curva C indica presión negativa por disfunción tubárica y la curva Ad indica luxación de cadena o tímpano monomérico.

PREGUNTA 24 **Respuesta: A**

Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

6.03.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno de deglución" (6.03.1.032), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

6.03.1.033 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pregunta difícil y discutible, pero se resumen en "¿Cuál es el examen de elección ante la sospecha de hipoacusia congénita?" y la respuesta es potenciales evocados auditivos. Las emisiones otoacústicas son una opción más barata, como screening en los pacientes asintomáticos, pero si hay una sospecha, lo ideal es pedir potenciales evocados. Eso sí, a los 4 años es posible que el paciente ya coopere en la audiometría, por lo que técnicamente es una mala pregunta.

PREGUNTA 26 **Respuesta: C**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Hipoacusia Sensorioneural Súbita (HSNS) derecha, una verdadera emergencia médica en ORL. La otoscopía normal descarta patología de oído externo o perforaciones, y el Weber al oído contralateral (izquierdo) con Rinne positivo confirma daño sensorioneural en el oído derecho. La única terapia con sólida evidencia que previene la sordera permanente es la corticoterapia oral en altas dosis (Prednisona 1 mg/kg/día por 10-14 días) iniciada de manera precoz en las primeras horas, complementada con audiometría urgente. Las opciones A y D son errores graves en oído con tímpano sano, y diferir la conducta (opciones B y E) conlleva secuelas irreversibles.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

La opción correcta es la B. La presbiacusia es la pérdida auditiva fisiológica relacionada con el envejecimiento, caracterizada por hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica y de predominio en frecuencias agudas, con dificultad desproporcionada para la discriminación fonémica en ambientes ruidosos. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más cuenta con Garantía Explícita en Salud (GES N° 56), que asegura el acceso a confirmación diagnóstica, entrega e implementación de audífonos y rehabilitación auditiva integral.

PREGUNTA 28 **Respuesta: C**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

La opción correcta es la C. El trauma acústico crónico por exposición laboral a ruido de alta intensidad (> 85 dB) produce un daño selectivo irreversible en las células ciliadas externas basales de la cóclea, lo que se traduce típicamente en la audiometría tonal como una caída o muesca ('escotoma acústico') simétrica en la frecuencia de 4000 Hz (y en menor medida 3000 o 6000 Hz), con recuperación relativa en los 8000 Hz.

PREGUNTA 29 **Respuesta: C**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

La opción correcta es la C. La Resonancia Magnética (RMN) de peñasco, conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso con medio de contraste (gadolinio) y secuencias finas potenciadas en T1 y T2 (CISS o FIESTA) es el examen de elección para detectar schwannomas vestibulares intracanaliculares incipientes (< 5 mm) que no son visibles en el TAC.

PREGUNTA 30 **Respuesta: A**

6.03.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 92). Evalúa el manejo clínico de Hipoacusia neonatal según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 31 **Respuesta: E**

6.03.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

Barotrauma: El caso describe un barotrauma típico, que se presenta en situaciones con cambios de presión atmosférica, como el buceo, viajes en avión, cambios bruscos de altitud, etc.

PREGUNTA 32 **Respuesta: E**

6.03.2.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 110). Evalúa el manejo clínico de Sordera súbita según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 33 **Respuesta: A**

6.03.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome de apnea del sueño" (6.03.1.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 34 **Respuesta: E**

6.03.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 141). Evalúa el manejo clínico de Síndrome respirador bucal según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 35 **Respuesta: A**

6.03.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

Tríada de Ménière: vértigo episódico + hipoacusia neurosensorial fluctuante + tinnitus, todo ipsilateral, episodios de horas = enfermedad de Ménière. El VPPB dura segundos y no tiene hipoacusia.

PREGUNTA 36 **Respuesta: D**

6.03.2.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

Es una neuronitis vestibular clásica. La ausencia de síntomas auditivos descarta la parálisis cócleovestibular (que es una sordera súbita: cócleo + una neuronitis vestibular: vestibular) y el hídrops endolinfático (o enfermedad de Ménière). El vértigo postural se desencadena con movimientos de la cabeza.

BLOQUE 3 RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: D** **Disfonías crónicas**

6.03.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Toda disfonía crónica se estudia con NFC. En este caso, además, el cuadro clínico sugiere cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada la NFC.

PREGUNTA 38 **Respuesta: A** **Sinusopatías crónicas**

6.03.1.030 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parecía una rinitis crónica, con predominio de síntomas obstructivos, por lo que de primera línea se deben indicar corticoides tópicos.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A** **Otorragia**

6.03.2.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Otorragia" como urgencia clínica (6.03.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 40 **Respuesta: C**

Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. El paciente cumple el criterio diagnóstico formal de Rinosinusitis Bacteriana Aguda (RSBA) al presentar síntomas cardinales de rinosinusitis (obstrucción, rinorrea purulenta, dolor facial) persistentes por más de 10 días sin ninguna evidencia de mejoría clínica. Este criterio temporal de persistencia es el más sensible para diagnosticar sobreinfección bacteriana secundaria. La conducta de primera línea establecida por las guías clínicas es iniciar tratamiento antibiótico oral con Amoxicilina (o amoxicilina con ácido clavulánico) por 7 a 10 días, asociada a lavados con solución salina. Mantener solo analgésicos a los 12 días (opción B) prolonga el cuadro y expone a complicaciones.

PREGUNTA 41 **Respuesta: B**

Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La presencia de signos de afección postseptal como proptosis (exoftalmos) y oftalmoplejía con diplopía dolorosa, en ausencia de una colección delimitada visible o amaurosis, define el Estadio II de Chandler (Celulitis Orbitaria postseptal). En el Estadio I (celulitis preseptal), el edema se confina a la dermis palpebral anterior y los movimientos oculares están rigurosamente conservados sin proptosis. Requiere hospitalización inmediata, TAC con contraste y antibióticos endovenosos de amplio espectro.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Una vez identificado el punto sangrante específico en el plexo de Kiesselbach (porción anteroinferior del tabique nasal) tras una compresión digital no resolutiva y preparación con vasoconstrictor tópico, el tratamiento estándar de elección es la cauterización química puntual del vaso con un bastón de nitrato de plata al 75%. La cauterización debe aplicarse de forma suave y concéntrica alrededor del vaso sangrante. La opción D es un grave error médico que causa necrosis y perforación del cartílago septal; la opción E induce deglución de sangre y vómitos; y las opciones A y C son medidas desproporcionadas para una epistaxis anterior puntual.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B**

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La epistaxis posterior que requiere taponamiento con balón o sonda Foley es una situación clínica grave que exige HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA del paciente por riesgo de hipoxia, bradiarritmias por reflejo nasovagal y aspiración. Además, la presencia de taponamiento posterior ocluye el ostium de drenaje de los senos paranasales y favorece la proliferación bacteriana en tejidos retenidos, lo que hace mandatorio el inicio de profilaxis antibiótica sistémica (habitualmente amoxicilina con ácido clavulánico o cefazolina) para prevenir el temible Síndrome de Shock Tóxico estafilocócico y la rinosinusitis aguda supurada. El balón se insufla con agua (nunca aire, que se desinfla por difusión) y solo con 8-10 mL para evitar necrosis tisular.

PREGUNTA 44 **Respuesta: B**

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. El Plexo de Kiesselbach (o Área de Little) es una red vascular ricamente anastomosada en la submucosa de la porción anteroinferior del tabique nasal, donde confluyen ramas de la arteria esfenopalatina, palatina mayor, labial superior y etmoidal anterior. Es el sitio anatómico de origen de más del 90% de las epistaxis anteriores.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. El cartílago del tabique nasal (cartílago cuadrangular) es avascular y se nutre exclusivamente por difusión a partir del pericondrio que lo recubre bilateralmente. Si se cauteriza de forma química o eléctrica ambas caras del tabique al mismo nivel simultáneamente, se destruye el aporte sanguíneo de ambos lados, provocando necrosis isquémica del cartílago subyacente y una perforación septal permanente, complicación grave y de difícil reparación quirúrgica.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A**

6.03.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Epistaxis a repetición" (6.03.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 47 **Respuesta: A**

6.03.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Epistaxis leve" (6.03.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

6.03.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Epistaxis masiva" como urgencia clínica (6.03.2.011), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

4.02.4.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

La opción correcta es la B. La presencia de una tumefacción abombada violácea y fluctuante en el tabique nasal tras un traumatismo agudo es la manifestación clínica típica del Hematoma Septal. Es una emergencia otorrinolaringológica: el cartílago septal sufre necrosis isquémica por desprendimiento del pericondrio en menos de 24 a 48 horas si no se descomprime, lo que provocaría la pérdida de soporte de la pirámide nasal (deformidad en silla de montar). La conducta inmediata ineludible es el drenaje quirúrgico de los coágulos mediante incisión del mucopericondrio, colocación de taponamiento anterior bilateral compresivo y cobertura antibiótica. Diferir la conducta (opción C) o usar descongestionantes (opción A) conduce a secuelas estéticas y funcionales irreparables.

PREGUNTA 50 **Respuesta: B**

6.03.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

El tratamiento de los pólipos nasales es con corticoides orales. Si solo hubiese tenido la rinitis alérgica, con obstrucción, pero sin pólipos, el tratamiento serían los corticoides tópicos.

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

6.03.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Fractura nasal reciente" como urgencia clínica (6.03.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 52 **Respuesta: B**

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

La opción correcta es la B. De acuerdo con la clasificación de consenso ARIA, el paciente tiene síntomas ≥ 4 días a la semana durante ≥ 4 semanas (lo que define el patrón 'Persistente') y presenta alteración del sueño y deterioro de su rendimiento de estudio (lo que define la categoría 'Moderada a Severa'). Para la rinitis alérgica persistente moderada-severa, la terapia de primera línea más eficaz y recomendada son los Corticoides Intranasales (fluticasona, mometasona o ciclesonida), que actúan sobre todos los mediadores inflamatorios y son superiores a los antihistamínicos orales en el alivio de la obstrucción nasal.

PREGUNTA 53 **Respuesta: B**

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

La opción correcta es la B. Los vasoconstrictores tópicos alfa-adrenérgicos (oximetazolina, tramazolina, fenilefrina) producen taquifilaxia y vasodilatación paradójica de rebote ('rinitis medicamentosa') si se utilizan por más de 5 a 7 días consecutivos. La conducta obligatoria consiste en la suspensión inmediata y definitiva del fármaco vasoconstrictor y el inicio de corticoides tópicos intranasales (como fluticasona o mometasona) para reducir la hipertrofia e inflamación endotelial de los cornetes.

PREGUNTA 54 **Respuesta: A**

6.03.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Obstrucción nasal crónica" (6.03.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

BLOQUE 4 FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A** **Estridor laríngeo**

6.03.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 86). Evalúa el manejo clínico de Estridor laríngeo según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A** **Tinitus**

6.03.1.031 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tinitus" (6.03.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 57 **Respuesta: D** **Perforación timpánica traumática**

6.03.2.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Perforación timpánica traumática: mantener seco el oído y controlar, la mayoría cierra espontáneamente en semanas. Nunca lavar.

PREGUNTA 58 **Respuesta: C**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

La opción correcta es la C. El paciente suma exactamente 5 puntos en la escala de McIsaac: fiebre > 38°C (+1), exudado amigdalino (+1), adenopatías anteriores sensibles (+1), ausencia de tos (+1) y edad de 3 a 14 años (+1). Con 5 puntos, la probabilidad de infección por Streptococcus pyogenes supera el 50-60%, estando formalmente indicado el inicio inmediato de tratamiento antibiótico de primera línea: Penicilina Benzatina intramuscular en dosis única o Amoxicilina oral (50 mg/kg/día) durante 10 días completos con el objetivo primordial de prevenir la fiebre reumática aguda.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Es una regla de oro de la infectología y pediatría: el tratamiento antibiótico adecuado de la faringitis estreptocócica previene de manera categórica la aparición de la Fiebre Reumática Aguda y sus secuelas valvulares cardíacas, siempre que se administre penicilina benzatina o se completen 10 días de antibióticos orales. Por el contrario (opción A), los antibióticos NO previenen la Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE), la cual depende de una respuesta inmune mediada por inmunocomplejos y antígenos nefritogénicos que se activa independientemente de la erradicación bacteriana. La opción E es falsa: el SBHGA mantiene un 100% de sensibilidad a la penicilina.

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La aparición de un exantema máculo-papular eritematoso difuso (rash por aminopenicilinas) en más del 90-95% de los pacientes con Mononucleosis Infecciosa por Virus de Epstein-Barr (EBV) tras recibir amoxicilina o ampicilina es un efecto inmunomediado clásico no alérgico. La presencia de odinofagia prolongada, exudado amigdalino, adenopatías en cadena cervical posterior y epitrocleares, sumado a esplenomegalia, confirma el síndrome mononucleósico.

PREGUNTA 61 **Respuesta: C**

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. Ante un antecedente fidedigno de reacción alérgica grave anafiláctica mediada por IgE (edema laríngeo, broncoespasmo o shock anafiláctico) a las penicilinas, están terminantemente contraindicados todos los antibióticos betalactámicos, incluyendo aminopenicilinas (opciones A y E) y cefalosporinas (opciones B y D) por riesgo de reacción anafiláctica cruzada potencialmente mortal. En esta situación clínica, los macrólidos (Azitromicina 500 mg/día por 5 días o Claritromicina 250-500 mg cada 12 horas por 10 días) constituyen la alternativa terapéutica formal de elección.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A**

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

6.03.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Amigdalitis aguda" (6.03.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A**

Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

6.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Amigdalitis crónica" (6.03.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 64 **Respuesta: B**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El cuadro clínico corresponde a un Absceso Periamigdalino derecho (quinsy), caracterizado por la tríada clásica de trismus, voz en papa caliente y desviación contralateral de la úvula provocada por la colección purulenta en el espacio periamigdalino. La conducta de elección que proporciona confirmación diagnóstica y alivio sintomático inmediato es la punción aspirativa con aguja o la incisión y drenaje en el punto de máxima fluctuación del pilar anterior, asociada al inicio inmediato de antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro con cobertura para anaerobios (Amoxicilina-Clavulánico o Penicilina + Metronidazol). Mantener tratamiento oral (opción A) es una conducta errónea ante una colección purulenta fascial.

PREGUNTA 65 **Respuesta: A**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la A. En niños menores de 5 años, la inflamación y supuración de los ganglios linfáticos retrofaríngeos de Gilette origina el Absceso Retrofaríngeo. Sus manifestaciones cardinales son fiebre, sialorrea, rigidez de nuca con tortícolis, estridor inspiratorio y ensanchamiento del espacio prevertebral visible en la radiografía lateral de cuello en inspiración. La complicación más grave y potencialmente letal es la propagación de la infección purulenta a través del 'espacio peligroso' (danger space) hacia el tórax, originando una Mediastinitis Necrotizante Descendente con shock séptico y alta mortalidad. Requiere hospitalización inmediata en UCI, TAC de cuello con contraste y drenaje quirúrgico en quirófano.

PREGUNTA 66 **Respuesta: B**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El trismus en las infecciones faríngeas profundas se debe a la inflamación por contigüidad, espasmo e hipertonía refleja de los músculos masticadores, específicamente del músculo pterigoideo interno (o medial), el cual se sitúa inmediatamente lateral al músculo constrictor superior de la faringe y al espacio periamigdalino.

PREGUNTA 67 **Respuesta: B**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El paciente presenta una Angina de Ludwig, una celulitis gangrenosa rápidamente progresiva de los espacios submandibular, sublingual y submentoniano originada típicamente a partir de focos odontogénicos inferiores. El signo de máxima alarma es la induración leñosa del piso de boca que eleva y propulsa la lengua hacia la orofaringe posterior, causando una obstrucción mecánica inminente y letal de la vía aérea superior. La prioridad clínica número uno indiscutida es el aseguramiento expedito de la vía aérea (mediante intubación con fibrobroncoscopio o traqueostomía de urgencia), antes de intentar cualquier procedimiento quirúrgico de drenaje o exámenes complementarios.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

6.03.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es un absceso periamigdalino clásico.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

6.03.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Absceso profundo de cuello" como urgencia clínica (6.03.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 70 **Respuesta: A**

Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

6.03.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Absceso retrofaríngeo" como urgencia clínica (6.03.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

4.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El paciente presenta un Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) infantil severo con repercusión en el desarrollo físico y amígdalas grado 4 que colapsan la orofaringe. El SAHOS pediátrico documentado secundario a hipertrofia de amígdalas y adenoides es la indicación quirúrgica absoluta indiscutida de adenoamigdalectomía. Postergar la intervención quirúrgica (opción D) expone al niño a fallo de medro, alteraciones ortodóncicas craneofaciales irreversibles y riesgo de hipertensión pulmonar / cor pulmonale crónico.

PREGUNTA 72 **Respuesta: D**

Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

6.03.1.025 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene clínica de rinitis. Por ser más intensa en las mañanas y con los cambios de temperatura, es de tipo vasomotora. Otras cosas clásicas de la rinitis vasomotora es que empeora con el estrés, con alimentos muy calientes o condimentados. El cáncer se presenta como obstrucción y rinorrea serosanguinolenta unilateral. Los pólipos se ven en pacientes jóvenes y suelen ser bilaterales, con marcada obstrucción y sí pueden tener rinorrea o sinusitis secundarias.

BLOQUE 5 CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** **Odinofagias agudas** 6.03.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Odinofagias agudas" (6.03.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** **Atresia coanal congénita** 6.03.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Atresia coanal congénita" como urgencia clínica (6.03.2.005), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 75 **Respuesta: B**

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

4.02.7.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La pila de botón en una cavidad mucosa como la fosa nasal o el CAE es una emergencia quirúrgica de máxima prioridad debido a la rápida producción de quemaduras químicas alcalinas graves por electrólisis y fuga de hidróxido de potasio, las cuales pueden ocasionar perforación del cartílago septal en menos de 2 horas. La extracción debe realizarse de forma inmediata por personal entrenado con instrumental específico (gancho romo introducido por detrás del objeto). Está estrictamente contraindicada la irrigación con agua o suero (opción A) porque los líquidos actúan como electrolito conductor que acelera catastróficamente la corriente eléctrica y la destrucción tisular.

PREGUNTA 76 **Respuesta: B**

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

4.02.7.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. En pediatría, la presencia de rinorrea purulenta, persistente, UNILATERAL y con OLOR FÉTIDO de varias semanas de evolución en un niño pequeño es el cuadro clínico clásico y patognomónico de un Cuerpo Extraño Nasal retenido y desapercibido (como fragmentos de esponja, papel o goma). La impactación del objeto bloquea el drenaje fisiológico de la mucosa y genera sobreinfección bacteriana local crónica anaerobia responsable de la fetidez extrema. Requiere rinoscopía anterior o nasofibroscopía inmediata para visualización y extracción.

PREGUNTA 77 **Respuesta: A**

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

6.03.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cuerpo extraño en el oído" como urgencia clínica (6.03.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 78 **Respuesta: A**

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

6.03.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cuerpo extraño en el esófago" como urgencia clínica (6.03.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 79 **Respuesta: D**

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

6.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

E? Por la tos áfona y el estridor es un cuerpo extraño laríngeo, pero por la sialorrea y la reticencia a comer era esofágico. Esta pregunta inducía a error. Yo marqué laríngeo, porque le di más importancia a los síntomas laríngeos.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

6.03.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cuerpo extraño nasal" como urgencia clínica (6.03.2.010), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

4.02.5.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. La presentación clínica de aumento de volumen y dolor paroxístico desencadenado por el estímulo alimentario ('cólico salival') es patognomónica de Sialolitiasis. El 80 a 90% de los cálculos salivales se originan en la glándula submandibular y se impactan en su conducto excretor principal, el conducto de Wharton, el cual discurre por el piso de la boca hasta desembocar en las carúnculas sublinguales a ambos lados del frenillo lingual.

PREGUNTA 82 **Respuesta: B**

Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

4.02.5.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El tumor más frecuente de las glándulas salivales es el Adenoma Pleomorfo (tumor mixto benigno), el cual asienta en más del 80% de los casos en la glándula parótida. Su presentación clínica es clásica: nódulo parotídeo indoloro, móvil, de consistencia elástica y crecimiento lento de meses o años, con integridad rigurosa de la función del nervio facial (VII par). El tratamiento de elección estándar es la Parotidectomía Superficial con identificación, disección y preservación del nervio facial. La enucleación simple (opción D) está formalmente contraindicada debido a que presenta un riesgo de recidiva local superior al 40% y riesgo de transformación maligna a carcinoma.

PREGUNTA 83 **Respuesta: C**

Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

6.03.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una sialoliGasis clásica. La obstrucción produce dolor y aumento de volumen súbitos. La desobstrucción puede ser intermitente. El tratamiento suele ser con analgésico y, si se ve el cálculo a la salida del conducto salival, es posible reGrarlo.

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

4.02.6.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

La opción correcta es la B. En un adulto fumador mayor de 40 años, una masa cervical pétrea fija es una metástasis ganglionar de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario. El método diagnóstico citológico de primera línea indiscutido es la Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía, la cual permite tipificar la neoplasia con alta sensibilidad sin diseminar células tumorales. Al mismo tiempo, está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO realizar una biopsia incisional o abierta del ganglio sin haber evaluado la vía aérea superior y sin PAAF previa, debido a que la apertura quirúrgica rompe las fascias cervicales, produce siembra tumoral extracapsular masiva, deteriora el pronóstico y complica gravemente el posterior vaciamiento ganglionar cervical radical.

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

4.02.6.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

La opción correcta es la B. La otalgia referida o refleja unilateral en presencia de un oído completamente sano (otoscopía normal) es una de las banderas rojas oncológicas más características de los tumores malignos del tracto aerodigestivo superior. El dolor se transmite por vía refleja a través de ramos sensitivos de los nervios craneales que inervan tanto la orofaringe/hipofaringe como el oído (el nervio glosofaríngeo a través del nervio timpánico de Jacobson, y el nervio vago a través del nervio auricular de Arnold). En todo adulto, especialmente si tiene antecedentes de tabaco o alcohol, este hallazgo exige nasofibroscopía inmediata para buscar un cáncer primario en amígdalas, base de lengua o laringe.

PREGUNTA 86 **Respuesta: A**

6.03.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de boca, labios y orofaringe" (6.03.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 87 **Respuesta: C**

6.03.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

Es un clásico cáncer de hipofaringe. El cáncer de laringe suele presentar disfonía progresiva, sin los otros síntomas. El cáncer de esófago presenta disfagia lógica, sin los otros síntomas.

PREGUNTA 88 **Respuesta: C**

6.03.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

La disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía (más aún cuando se sospecha un cáncer de laringe, como en este caso).

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

6.03.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer nasosinusal" (6.03.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 90 **Respuesta: D**

6.03.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

Es un quiste del conducto Grogloso clásico. La ubicación en la línea media, suprahioidea es lo más característico.
